

ASCITIS

Joaquín Llorente García, María Elena Aguirre Alastuey, Cristina Sardiña González

INTRODUCCIÓN

La ascitis es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Las causas son muchas, la más frecuente la cirrosis hepática (80%).

Clasificación de la ascitis

Grado de ascitis	Definición	Tratamiento
Grado I	Ascitis leve (< 500 ml), asintomática, se detecta solo con ecografía	No requiere
Grado II	Ascitis moderada. Presenta distensión simétrica moderada del abdomen. Puede presentar molestias abdominales. Vida relativamente normal	Restringir ingesta de sodio y diuréticos.
Grado III	Ascitis grave o a tensión (> 1,5L), presenta malestar general, anorexia, gran distensión abdominal, náuseas, a veces disnea (por derrame pleural o elevación diafragmática) y hernias.	Paracentesis de gran volumen, restringir ingesta de sodio y diuréticos.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en una historia clínica exhaustiva (anamnesis, examen físico), análisis de laboratorio, pruebas de imagen y estudio de líquido ascítico.

Antecedentes personales

Hay que interrogar por factores de riesgo de hepatopatía (consumo alcohol, hepatitis, transfusiones, adicción a drogas vía parenteral, obesidad, diabetes, dislipemia, familiares con historia de hepatopatía), riesgo de patología tumoral (síndrome general, alteración en el tránsito gastrointestinal y síntomas ginecológicos) y antecedentes de insuficiencia cardíaca.

Clínica

Los síntomas dependen de la cantidad de líquido (menos de 500-1000 ml puede ser asintomática). Los más frecuentes son distensión abdominal, aumento de peso, plenitud postprandial, náuseas, vómitos y disnea.

Exploración física

- **Confirman el diagnóstico:** la oleada ascítica y la matidez cambiante en flancos suele ser positiva a partir de 500-1000 ml, dependiendo de la obesidad del paciente. Hepatoesplenomegalia, circulación colateral, hernias abdominales, edema de pene y escrotal, derrame pleural o edemas en miembros inferiores.
- **Signos que orientan la etiología:**
 - Anasarca: ICC o síndrome nefrótico.
 - Ictericia: hepatopatía.
 - Ginecomastia, arañas vasculares, hipertrofia parotídea, eritema palmar: etilismo crónico.
 - Aumento de presión venosa yugular y soplos cardíacos: Insuficiencia cardíaca congestiva.
 - Masas abdominales o adenopatías: tumoral.
 - Irritación peritoneal: peritonitis.

- Ingurgitación venosa yugular: insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva.

Pruebas complementarias:

- **Hemograma:** citopenias en hipertensión portal (HTP), anemia en tumores o leucocitosis en infección.
- **Coagulación:** alteración protrombina en cirróticos.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, GGT, bilirrubina, amilasa, fosfatasa alcalina, proteínas totales, albúmina, PCR. La albúmina baja en hepatopatía y síndrome nefrótico, creatinina y urea alta en enfermedad renal crónica, inversión de GOT/GPT en etilismo crónico, amilasa alta en la ascitis pancreática.
- **Gasometría arterial.** Si disnea
- **Hemocultivos.** Si fiebre
- **Sistemático** y sedimento de orina con iones en orina y proteinuria.
- **ECG:** arritmias y datos de cardiopatía.
- **Radiografía de tórax** posteroanterior y lateral: cardiomegalia y derrame pleural.
- **Radiografía de abdomen:** neumoperitoneo, asas centradas, borramiento de la línea del musculo psoas.
- **Ecografía abdomen:** prueba de imagen de elección en urgencias. Confirma el diagnóstico, orienta a la etiología (hepatopatía, trombosis portal o suprahepáticas, LOES hepáticas, neoplasias) y dirige la paracentesis.
- **TC abdomen.** Según clínica.
- **Paracentesis diagnóstica:** técnica fundamental, debe hacerse siempre:
 - Primer episodio y en sospecha de infección para descartar peritonitis bacteriana espontánea.
 - Ascitis conocida si se asociada a fiebre, dolor abdominal, leucocitosis, aumento de la ascitis, peritonismo, encefalopatía hepática, alteración de función hepática y función renal.

Estudio del líquido ascítico: Hay que pedir inicialmente el estudio de:

- Recuento celular, albúmina, proteínas totales, LDH y glucosa. En función de la sospecha se puede pedir también
- Estudio microbiológico, tinción de gram y micobacterias, ADA, PCR de tuberculosis, amilasa, citología, triglicéridos, bilirrubina y cultivo de líquido ascítico.

El aspecto puede ayudar:

- Lechoso. En caso de infección o ascitis quillosa.
- Hemático. En cirrosis o patología tumoral.

Lo primero a descartar es una Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE), definida como > 250 PMN/mm³ en líquido ascítico. Si hay 2 de 3 de:

- Proteínas totales > 1 g/dL
- Glucosa < 50 mg/dL y
- LDH en límite mayor en suero hay que descartar perforación gastrointestinal con Peritonitis Secundaria y solicitar un TC abdomen.

Para diferenciar la ascitis debida a hipertensión portal de otras causas se debe de medir el gradiente de albumina suero-ascitis (GASA), si el GASA es igual o mayor que 1,1 g/dL (o 11 g/L), la ascitis se puede atribuir a hipertensión portal con una alta probabilidad: 97% y si es menor se

descarta HTP. Después de medir el gradiente albúmina sérica – albúmina ascítica (GASA) para determinar si hay HTP (ver tabla) y enfocar el diagnóstico etiológico y tratamiento.

Tabla 1. Causas de ascitis

GASA > 1,1g/dL (o 11g/L) – HTP	GASA < 1,1g/L (o 11g/L) – SIN HTP
• Cirrosis hepática	• Carcinomatosis peritoneal
• Cáncer hepático/metástasis	• PBE
• Hepatitis aguda alcohólica	• Peritonitis tuberculosa
• Fallo hepático fulminante	• Vasculitis
• Enfermedad venooclusiva hepática	• Peritonitis granulomatosa
• Insuficiencia cardíaca	• Procesos ginecológicos
• Trombosis vena porta	• Síndrome nefrótico
• Síndrome de Budd-Chiari	• Desnutrición • Ascitis pancreática • Ascitis quílosa

TRATAMIENTO

El tratamiento será el específico según la etiología.

Medidas generales:

- Evitar alcohol y otros tóxicos hepáticos.
- Evitar consumo de AINES.
- Restricción de sodio a 80-120 mmol/día, que corresponde a 4,6-6,9 g de sal/día.
- Restricción de líquidos.

Medidas específicas:

- Tratar las causas
- **Ascitis leve o grado I**: no precisa tratamiento.
- **Ascitis moderada o grado II**: diuréticos.
- **1. Antagonista de la aldosterona: espironolactona.** Se puede tratar ambulatoriamente si no existe complicaciones. En pacientes con primer episodio de Ascitis grado II, deberán de recibir tratamiento con antagonistas de la aldosterona: espironolactona (iniciar con 100mg/día e ir subiendo dosis paulatinamente cada 7 días en intervalos de 100mg/día hasta un máximo de 400mg/día: Nivel A1) con o sin furosemida.
- **2. Diurético de asa: furosemida.** Se agregará furosemida 40 mg/día (se inicia con 40mg/día hasta 160mg/día, con intervalos de 40mg. Nivel A1) si no responde a espironolactona (si la reducción de peso corporal es inferior a 2kg / semana) o pacientes con hiperkalemia. La pérdida de peso máxima recomendada durante el tratamiento diurético debe ser de 0,5 kg/día en pacientes sin edemas y de 1 kg/día en pacientes con edemas (Nivel A1).

Se suspenderán temporalmente todos los diuréticos si hay:

- Hiponatremia severa (concentración sérica de sodio <120 mmol/L).

- Fallo renal progresivo.
- Empeoramiento de la encefalopatía hepática o
- Calambres musculares incapacitantes (Nivel B1).

La furosemida se debe suspender si hay hipokalemia severa: < 3 mmol/L. La espironalactona se debe suspender si los pacientes desarrollan hiperkalemia severa: potasio sérico > 6 mmol/L.

- **3. Ascitis severa o grado III.** Paracentesis evacuadoras en ascitis a tensión o moderada a pesar de tratamiento médico. Las paracentesis de gran volumen (PGV) es el método de elección: Si PGV < 5 litros: el riesgo es bajo de desarrollar disfunción circulatoria post-paracentesis, pero se recomienda el uso de albúmina. Si PGV > 5 litros se recomienda usar albúmina (8 g de albúmina por litro de líquido ascítico evacuado: 1 frasco de albúmina 50ml al 20% por cada litro de ascitis evacuado), otros expansores plasmáticos distintos a la albúmina no se recomienda.
- **Ascitis refractaria:** PGV repetidas luego transfundir albúmina IV: 8 g por litro de líquido ascítico evacuado.
- **Tratamiento de la PBE:**
- **1. Antibiótico:** iniciar con la sospecha, sin esperar al recuento celular. Cefotaxima 2g/8h o Ceftriaxona 2g/24h. Alternativo: amoxicilina - ácido clavulánico o ceftazidima o quinolonas.
- **2. Albúmina:** 1,5 g/kg en las primeras 6 horas y 1 g/kg a las 72 horas si creatinina > 1 mg/dL, urea > 30 mg/dL o bilirrubina > 4 mg/dL.

Complicaciones

- **Hiponatremia dilucional.** Cuando la concentración de sodio es < 130 mEq/L por la intensa disminución de excreción renal de agua libre, presentan clínica desde anorexia, náuseas, vómitos, confusión, debilidad muscular y coma. El tratamiento consiste: restringir los líquidos a 1 litro / día y suspender diurético cuando sodio sérico sea: Na < 120 mEq/L.
- **Peritonitis bacteriana espontánea.** Infección del líquido ascítico se deba de pensar en ausencia de foco infeccioso intraabdominal, tener presente a E.Coli como microorganismo implicado mas frecuentemente, ante clínica de dolor abdominal, fiebre, alteración de la función renal, encefalopatía hepática e hipotensión.
- **Síndrome hepato-renal.** Descartada otras causas de fallo renal. Existe un fracaso renal agudo (creatinina $> 1,5$ mg/dL) y progresivo hasta llegar a la oligoanuria. Iniciar tratamiento con terlipresina 1 mg/4h IV en bolo durante 14 días más albúmina 1 gr /kg.

BIBLIOGRAFÍA

- Ranyon BA. Introduction to the Revised American Association for the Study of Liver Diseases Practice Guideline Management of Adult Patients With Ascites Due to Cirrhosis 2012.Hepatology 2013;57:1651-1678
- Vázquez- Lima MJ. Casal Codesido J.R. Guía de actuación en Urgencias. 5ª ed. Ed.Panamericana 2017.
- Suarez-Pita D. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Medica Hospital Universitario 12 de Octubre. 8ª edición. 2016.
- Guías de práctica clínica de la EASL sobre el manejo de la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, y el síndrome hepatorenal en la cirrosis. European Association for the Study of the Liver (Asociación Europea para el Estudio del Hígado). Journal of Hepatology 2010 vol 53.Pag 397–417